

HealthMatch

Business Plan

Camada de contingência para escalas de saúde — começando pela Coaph

Versão	Piloto + Pre-seed (revisão pós-reunião Coaph)
Data	Junho / 2026
Estágio	Pré-lançamento — produto funcionalmente pronto
Âncora	Coaph (Fortaleza / CE) — cliente-âncora + financiador do piloto
Produto	Gap-filling: cobre a exceção (descobertas/no-shows), não toda a escala
Ask atual	Piloto de R\$ 300 mil (rodada plena de R\$ 1,5 mi depois do piloto)

Documento confidencial. Empresa em pré-lançamento, sem receita realizada. A economia parte de números informados pela Coaph (prepostos ~R\$ 240 mil/mês; plantão médico 12h = R\$ 1.200) e de premissas conservadoras e editáveis sobre o gap (💡). Sobrepreço emergencial e penalidade são as premissas de maior peso — o piloto existe para validá-las.

Sumário

1. Sumário executivo.....	3
2. O problema: o gap, não a escala inteira.....	4
3. A solução: uma camada de contingência.....	5
4. A tese de investimento (defensiva + ofensiva).....	6
5. Business Case para a Coaph.....	7
6. Modelo de receita.....	8
7. Mercado (upside da escala).....	9
8. Estratégia de Go-to-Market.....	10
9. Estrutura operacional e equipe.....	11
10. Plano financeiro do HealthMatch (escala).....	12
11. KPIs do piloto Coaph.....	13
12. Análise SWOT.....	14
13. Riscos e plano de mitigação.....	15
14. Recomendação de investimento.....	16
15. Roadmap.....	17

1. Sumário executivo

O HealthMatch é uma camada de contingência para escalas de saúde. Ele não gerencia toda a escala da cooperativa — resolve o gap: o plantão que não fecha, o no-show, a exceção de última hora. Usar a plataforma é a exceção, não a regra. É onde se concentram o maior custo, risco e dor.

O cliente-âncora é a Coaph, que hoje sustenta uma operação manual de prepostos (~R\$ 240 mil/mês) e arca com o custo do gap: telefonemas, sobrepreço de cobertura emergencial e penalidade/risco quando o plantão fica descoberto.

Duas teses, separadas e honestas

	Tese defensiva	Tese ofensiva
Lógica	Reduzir o custo do gap dentro da Coaph	Escalar a contingência para outras cooperativas/hospitais
Métrica	Economia operacional mensal	Receita recorrente (SaaS de prontidão + fee)
Papel	Justifica o PILOTO	Justifica a rodada plena (futura)

O que muda nesta revisão (após a reunião com a Coaph)

- Cobre o gap, não a escala inteira → volume menor, foco maior.
- Margem da cooperativa < 5% → monetização híbrida: SaaS de prontidão + fee por gap capado em ≤ 2%. Take-rate gordo sobre GMV foi descartado.
- Investimento redimensionado: o ask agora é um piloto de R\$ 300 mil (payback ~2,6 meses, realista) que prova as premissas antes de qualquer rodada maior.

Item	Resumo
Produto	Camada de contingência (gap-filling) com matching + IA no WhatsApp + financeiro
Cliente-âncora	Coaph — assina como cliente (ROI positivo desde o 1º mês)
Monetização	SaaS de prontidão (R\$ 8 mil/mês) + fee por gap (≤ 2% do plantão)
Ask atual	Piloto de R\$ 300 mil (payback ~2,6 meses)
Economia líquida (Coaph, realista)	~R\$ 114,7 mil/mês
Rodada plena	R\$ 1,5 mi depois do piloto, justificada pela escala (ofensiva)

Enquadramento honesto: como projeto de eficiência puro, a economia de prepostos sozinha não pagaria R\$ 1,5 mi rápido (~40 meses). Por isso a decisão se divide: a Coaph assina como cliente (ganha já) e financia um piloto enxuto que valida o custo real do gap; a rodada de equity maior fica para depois, decidida com dados.

2. O problema: o gap, não a escala inteira

A maior parte dos plantões a cooperativa preenche pelo seu processo regular. O problema caro é a exceção:

- Plantão que não fecha → penalidade contratual + risco assistencial.
- No-show → cobertura emergencial de última hora, quase sempre com sobrepreço.
- Horas de preposto desproporcionais gastas nessas exceções (o 20% de casos que consome 80% do esforço).

♦ Na Coaph, estima-se que ~35% do custo de prepostos (R\$ 240 mil/mês) esteja ligado a gaps/exceções, além do sobrepreço e das penalidades — valores que o piloto vai medir.

3. A solução: uma camada de contingência

O HealthMatch entra só quando o processo normal falha. Mantém um pool de contingência pronto e usa:

- Matching: cruza especialidade, CBO, credencial, no-show e conflito de agenda — e acha rápido quem pode cobrir.
- IA no WhatsApp: aborda, negocia e confirma a cobertura 24/7, com handoff humano em ações críticas.
- Financeiro: registra a cobertura e a margem com auditoria.

Resultado: o gap é coberto em minutos, de um pool pronto, sem o sobrepreço da urgência e sem horas de telefonema — reduzindo penalidade e risco.

Produto: funcionalmente completo e testado internamente (32/32 testes de API, 14/14 regras de negócio). Stack: NestJS + Prisma + PostgreSQL; Next.js; IA Anthropic; Twilio/WhatsApp; Docker. Lacunas para escala (roadmap): multi-tenancy, billing/split, observabilidade, ativação plena da IA.

4. A tese de investimento (defensiva + ofensiva)

Defensiva (justifica o piloto): reduzir o custo do gap na Coaph — tempo de preposto nas exceções + sobrepreço emergencial + penalidade por plantão descoberto. Mensurável e atacável já.

Ofensiva (justifica a rodada plena, depois): a mesma camada de contingência replicada para outras cooperativas e hospitais. É um SaaS de contingência — modesto e previsível (~R\$ 226 mil/ano por cliente), não um marketplace de take-rate gordo.

Regra de decisão: a Coaph assina como cliente (ganha mensalmente) e financia o piloto (R\$ 300 mil, payback ~2,6 meses). A rodada de equity de R\$ 1,5 mi só entra depois que o piloto comprovar a economia — justificada pela escala, não pela operação interna.

5. Business Case para a Coaph

Premissas (realista, a validar): gap ~600/mês; ticket ponderado R\$ 900 (médico R\$ 1.200, demais classes menores); 35% dos gaps com sobrepreço (R\$ 250/plantão); 6% ficariam descobertos (penalidade R\$ 1.200).

Economia mensal da Coaph (3 camadas)

Camada de economia	Conservador	Realista	Otimista
1) Tempo de preposto no gap	R\$ 25,2 mil	R\$ 37,8 mil	R\$ 50,4 mil
2) Sobrepreço emergencial evitado	R\$ 35,0 mil	R\$ 52,5 mil	R\$ 87,5 mil
3) Penalidade evitada	R\$ 28,8 mil	R\$ 43,2 mil	R\$ 72,0 mil
Economia bruta/mês	R\$ 89,0 mil	R\$ 133,5 mil	R\$ 209,9 mil
(-) Custo pago ao HealthMatch	(R\$ 15,2 mil)	(R\$ 18,8 mil)	(R\$ 26,0 mil)
Economia líquida/mês	R\$ 73,8 mil	R\$ 114,7 mil	R\$ 183,9 mil

Payback do investimento

Investimento	Conservador	Realista	Otimista
Piloto (R\$ 300 mil) — ask atual	~4,1 meses	~2,6 meses	~1,6 meses
Rodada plena (R\$ 1,5 mi) — futura	~20 meses	~13 meses	~8 meses
Floor honesto: só prepostos paga R\$ 1,5 mi	~60 m	~40 m	~30 m

- A economia depende sobretudo das camadas 2 e 3 (sobrepreço e penalidade) — as premissas mais incertas, que o piloto valida.
- Mesmo no conservador, o piloto se paga em ~4 meses.
- Como cliente, a Coaph é líquida-positiva todo mês (paga R\$ 18,8 mil, economiza R\$ 133,5 mil brutos) — assinar é um no-brainer operacional.

6. Modelo de receita

Dada a margem da cooperativa $< 5\%$, a receita do HealthMatch é híbrida e desacoplada do GMV:

SaaS de prontidão: mensalidade fixa pelo acesso ao pool de contingência (Coaph: ♦ R\$ 8 mil/mês). Previsível, não depende da margem fina.

Fee por gap preenchido: pequena taxa por cobertura, capada em $\leq 2\%$ do plantão ($\approx$ R\$ 24 num plantão médico de R\$ 1.200). Alinha receita ao valor entregue.

Receita do HealthMatch vinda da Coaph: $\sim$ R\$ 18,8 mil/mês (R\$ 226 mil/ano) no realista. O take-rate gordo sobre GMV não se aplica neste mercado.

7. Mercado (upside da escala — tese ofensiva)

Embasa a rodada plena (futura). A decisão do piloto não depende disto.

~562 mil médicos ativos (CFM, 2024); milhares de cooperativas e unidades. O gap (descobertas + no-shows) é universal e hoje resolvido na base do telefonema. Comps internacionais de staffing/contingência de saúde (Nomad, Trusted, Medely, ShiftMed; Patchwork no Reino Unido) validam a categoria. O concorrente nº 1 segue sendo o processo manual.

8. Estratégia de Go-to-Market

Fase 0 — Piloto Coaph (mês 0–6): implantar a contingência em 1–2 unidades/especialidades; medir baseline e economia real do gap.

Fase 1 — Coaph plena + 2ª cooperativa (mês 6–18): expandir o uso e abrir a primeira cooperativa adjacente com o case.

Fase 2 — Escala regional (mês 18–36): mais cooperativas e hospitais do NE.

Canal principal: indicação da Coaph e da rede cooperativista. A base de cooperados é vantagem de oferta uma vez operacionalizada — não liquidez automática.

9. Estrutura operacional e equipe

Fundador solo (bootstrap), produto construído. O piloto (R\$ 300 mil) financia: 1 engenheiro para hardening/integrações/LGPD, implantação na Coaph e a instrumentação dos KPIs (~6 meses). Contratações maiores (comercial/CS) ficam para a rodada plena.

10. Plano financeiro do HealthMatch (escala — ofensiva)

Cenário de upside (HealthMatch como empresa). Modesto e previsível — coerente com a margem fina. Não é a base da decisão do piloto.

Receita HM (escala)	Ano 1	Ano 2	Ano 3
Cooperativas/clientes ativos (média)	1	5	15
Receita/cliente/ano (realista)	R\$ 226 mil	R\$ 226 mil	R\$ 226 mil
Receita HM total/ano	R\$ 226 mil	R\$ 1,13 mi	R\$ 3,38 mi

É um SaaS de nicho saudável, não um foguete de marketplace. A rodada plena de R\$ 1,5 mi deve ser dimensionada a este plano — e só faz sentido após o piloto validar a economia e a adoção.

11. KPIs do piloto Coaph

O piloto mede a economia real do gap (não só o uso). Baseline antes; medição depois:

KPI	Meta no piloto
Custo de cobertura emergencial (sobrepçoço)	↓ — validar a camada 2
Nº de plantões descobertos / penalidades	↓ — validar a camada 3
Horas de preposto nas exceções	↓ — validar a camada 1
Tempo médio de cobertura do gap	de horas para minutos
% de gaps cobertos sem intervenção humana	↑ a cada ciclo
Taxa de aceite via WhatsApp/IA	estabelecer e crescer
Nº de gaps processados e profissionais ativados	crescimento
NPS dos coordenadores	≥ alvo acordado
Economia operacional mensal (estimada × realizada)	gatilho da rodada plena

12. Análise SWOT

Forças	Fraquezas
• Ataca o ponto de maior dor/custo (o gap) • Produto construído e testado • Coaph como cliente-âncora alinhado • Piloto barato com payback rápido	• Economia depende de premissas a validar (sobrepço/penalidade) • Fundador solo; sem tração externa • Dependência inicial da Coaph • Receita por cliente modesta (margem fina)
Oportunidades	Ameaças
• Replicar contingência para outras cooperativas • Hospitais e setor público • Categoria validada lá fora	• Coaph optar por resolver in-house • Margem fina limitar disposição a pagar • Economia do gap não se confirmar no piloto

13. Riscos e plano de mitigação

Risco	Prob./Imp.	Mitigação
Economia do gap não se materializar	Médio/Alto	Piloto barato (R\$ 300k) existe para validar antes de qualquer cheque maior; premissas conservadoras e editáveis
Virar software sob medida, não produto	Médio/Alto	Multi-tenant desde já; contrato de cliente separado do investimento
Dependência excessiva da Coaph	Médio/Alto	Abrir 2ª cooperativa após o piloto; dados/portabilidade garantidos
Margem fina limitar o que pagam	Médio/Médio	SaaS de prontidão desacoplado do GMV; fee capado e indolor
Resistência interna (prepostos)	Médio/Médio	Gestão de mudança; posicionar como apoio à exceção, não substituição total
Regulatório/trabalhista, LGPD	Médio/Alto	Jurídico especializado; cooperativa detém o vínculo; compliance no piloto
Fundador solo	Médio/Médio	Piloto financia 1ª contratação de eng.; cláusulas de IP/continuidade

14. Recomendação de investimento (piloto-first)

Decisão em camadas, desacopladas:

1. A Coaph deve assinar como cliente — agora. Paga ~R\$ 18,8 mil/mês e economiza ~R\$ 133,5 mil/mês (bruto). Decisão operacional de baixo risco e ROI imediato.
2. A Coaph deve financiar o piloto de R\$ 300 mil — agora. Payback ~2,6 meses (realista; ~4 no conservador). O piloto valida o custo real do gap (sobrepço + penalidade) e gera o case.
3. A rodada plena de R\$ 1,5 mi — depois. Só após o piloto comprovar a economia e a adoção, justificada pela tese ofensiva (escala). Decidida com dados, não com promessa.

Uso do piloto (R\$ 300 mil): hardening + integrações + LGPD; implantação na Coaph; instrumentação dos KPIs; 1 engenheiro por ~6 meses; comitê mensal Coaph + HealthMatch de acompanhamento do ROI.

Gatilho para a rodada plena: economia operacional realizada $\geq$ R\$ 100 mil/mês comprovada no piloto.

15. Roadmap

0–6 meses — Piloto Coaph (R\$ 300 mil): hardening/LGPD; implantar contingência; medir baseline e economia; comitê mensal de ROI.

6–18 meses — Coaph plena + 2ª cooperativa: expandir uso; abrir 1 cooperativa adjacente; preparar a rodada plena com o case comprovado.

18–36 meses — Escala (ofensiva): mais cooperativas/hospitais; rodada seed/plena com tração real.

Resumo da decisão: assine como cliente (ganha já) + financie um piloto enxuto (paga-se em meses) para provar o custo do gap. Adie a rodada grande até ter dados. Pior cenário aceitável: o piloto se paga e a Coaph fica com uma operação de contingência mais barata — sem ter arriscado R\$ 1,5 mi.